

Sub-estudio: COVID y hospitalizaciones por salud mental

¿Fue el COVID el responsable del aumento de las hospitalizaciones por salud mental? Análisis de quiebre de tendencia (2014-2026)

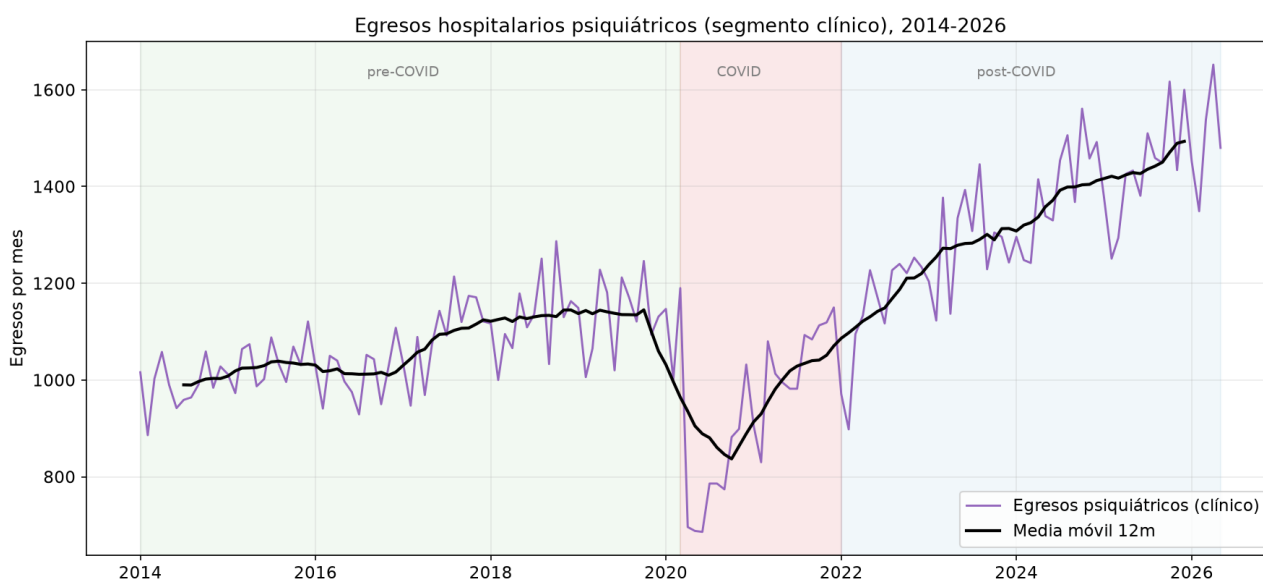
Análisis de Indicadores Hospitalarios · MINSAL REM20
Matías Durán · Data & Business Analyst

1. Pregunta de investigación

Este sub-estudio responde una pregunta concreta: ¿fue el COVID el responsable del aumento de las hospitalizaciones por salud mental? La pregunta no es si la pandemia afectó la operación hospitalaria —sí lo hizo—, sino si explica causalmente el alza posterior de las hospitalizaciones psiquiátricas, o si éstas ya seguían una trayectoria previa al COVID.

En REM20 la hospitalización por salud mental se cuantifica a través de los egresos (altas) de las unidades psiquiátricas: cada egreso corresponde a una hospitalización completada, de modo que el número de egresos es el indicador de volumen de hospitalización. Una precisión de alcance: este análisis mide hospitalizaciones (uso de camas psiquiátricas), no la incidencia de patologías psiquiátricas en la población —si hay más enfermedad mental—, que exige fuentes con diagnóstico clínico ajenas a REM20 y se aborda como una capa de análisis separada.

La fuente utilizada corresponde a rem20.indicadores del MINSAL REM20, con serie mensual entre 2014-01 y 2026-05, con 149 meses observados y 0 huecos. En el segmento psiquiátrico clínico, los egresos presentan una media cercana a 1.143 por mes, con mínimo de 686 y máximo de 1.652. La ocupación media de camas fue de 87,2%. El año 2026 debe leerse como año parcial.



Fuente: MINSAL REM20 2014-2026

Figura 1. Serie mensual de egresos psiquiátricos: tendencia ascendente previa a marzo de 2020, caída inicial durante el período COVID y recuperación posterior.

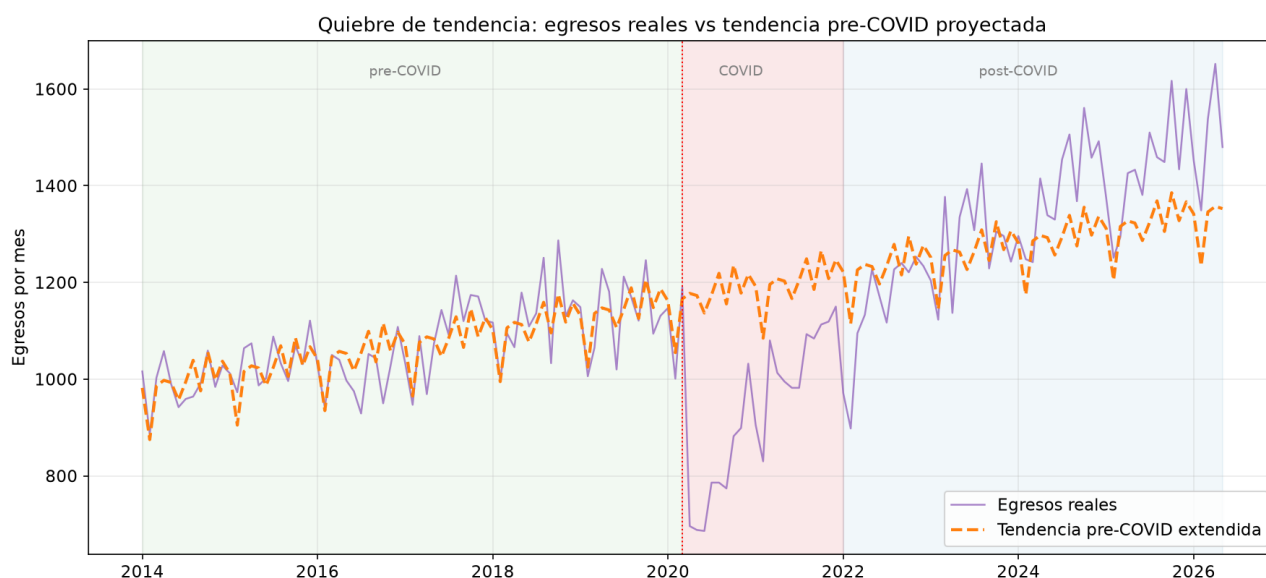
2. Metodología

El análisis utiliza tres aproximaciones complementarias. Primero, una regresión segmentada de series temporales interrumpidas, que estima la tendencia previa a marzo de 2020, el cambio inmediato de nivel en ese punto y la pendiente posterior, controlando la estacionalidad mensual. Para robustecer la inferencia temporal se usaron errores HAC, adecuados cuando los datos mensuales pueden presentar autocorrelación o variación no constante.

Segundo, se construyó un contrafactual: una extensión de la tendencia pre-COVID con banda de 95%. Esta comparación permite estimar cuánto se apartaron los egresos reales de lo que

se habría esperado si la trayectoria observada hasta febrero de 2020 hubiese continuado sin interrupción.

Tercero, se incorporó un grupo de control mediante diferencias en diferencias, comparando la evolución de psiquiatría clínica con el resto del sistema no psiquiátrico. Esta lectura no prueba causalidad clínica, pero ayuda a distinguir si el patrón post-COVID fue general del sistema hospitalario o diferencial del segmento psiquiátrico.



Fuente: MINSAL REM20 2014-2026

Figura 2. Egresos reales frente a la tendencia pre-COVID extendida: el aumento posterior se monta sobre una trayectoria ascendente ya existente.

3. Veredicto: no fue el COVID; la tendencia ya venía desde 2014

El veredicto técnico es claro: el COVID no fue la causa del aumento de hospitalización psiquiátrica. La evidencia principal es que los egresos psiquiátricos ya venían aumentando antes de la pandemia, con una pendiente pre-COVID de +30 egresos por mes por año (exactamente +29,97; $p < 0,0001$). Por lo tanto, el crecimiento no comienza en marzo de 2020.

Además, el quiebre de marzo de 2020 no produjo un salto positivo en egresos. Por el contrario, el modelo estima un cambio inmediato de nivel de -310 egresos por mes (exactamente $-309,97$; $p < 0,0001$). En términos operacionales, el COVID primero hundió los egresos psiquiátricos, coherente con una disrupción de la actividad hospitalaria y no con un aumento inicial de hospitalización.

La pendiente posterior sí fue más empinada que la tendencia previa: el cambio de pendiente post-COVID fue de +89 al año (exactamente +88,66; $p < 0,0001$). Sin embargo, esto debe interpretarse como recuperación y aceleración relativa respecto de una tendencia que ya existía, no como prueba de que el COVID haya causado el aumento estructural.

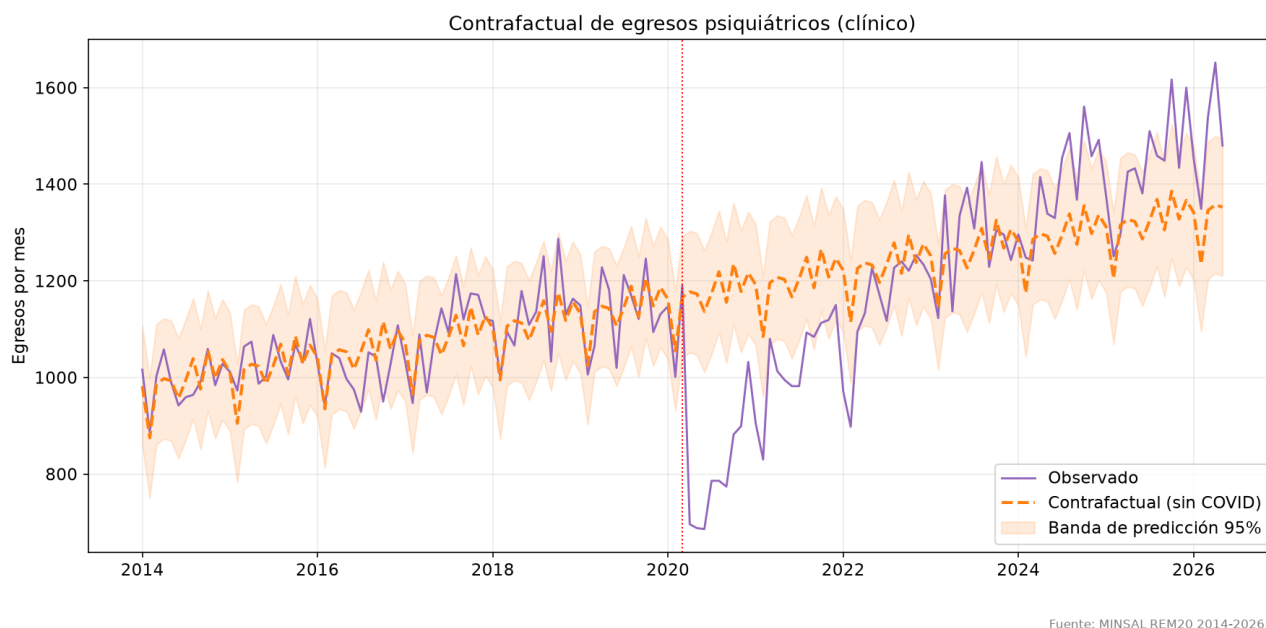


Figura 3. Contrafactual de egresos: brecha negativa durante 2020-2021 y brecha positiva moderada desde 2022, sin alterar que la tendencia ascendente era previa.

4. Matices

El primer matiz es la caída inicial de 2020-2021. Frente al contrafactual construido desde la tendencia pre-COVID, la brecha media fue de -249 egresos por mes durante 2020-2021. Este resultado es central: si el COVID hubiese sido el origen directo del alza, se esperaría un aumento inicial, pero lo observado fue una contracción importante del flujo de egresos.

El segundo matiz es el rebote diferencial posterior a 2022. En el período 2022-2026, psiquiatría clínica se ubicó $+4,0\%$ sobre lo esperado por la tendencia previa, equivalente a una brecha media de $+51$ egresos por mes. En comparación, el resto del sistema no psiquiátrico quedó $-5,2\%$ por debajo de lo esperado. La diferencia en diferencias fue de $+9,2$ puntos porcentuales a favor de psiquiatría. Esto indica un desempeño post-COVID diferencial del segmento, pero no transforma a la pandemia en causa del aumento de largo plazo.

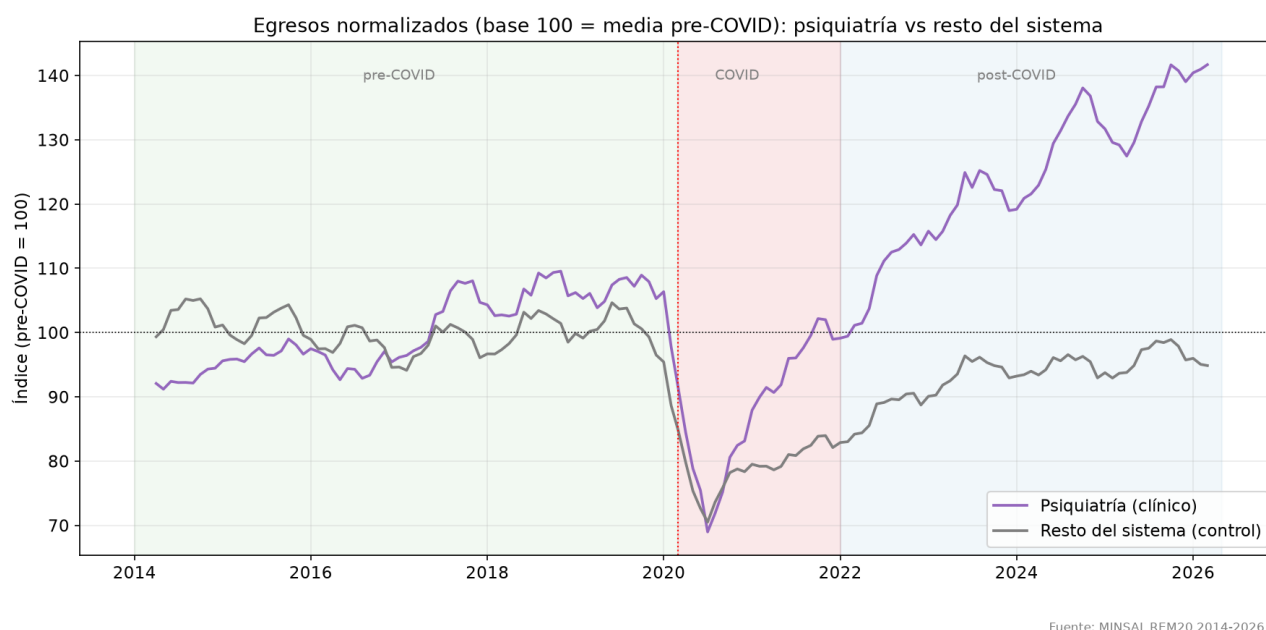
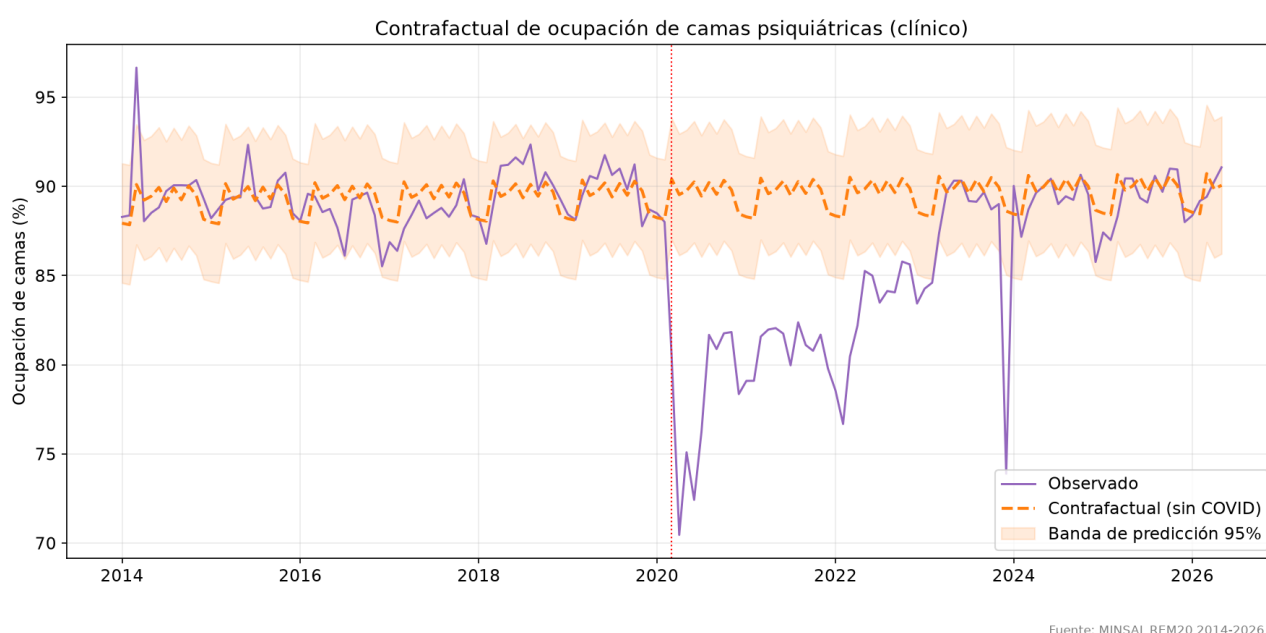


Figura 4. Egresos normalizados (base 100 = media pre-COVID): desde 2022 psiquiatría clínica supera su trayectoria previa mientras el resto del sistema permanece por debajo de lo esperado.

El tercer matiz es la diferencia entre flujo y stock. Los egresos miden rotación o volumen de salida hospitalaria; la ocupación de camas mide presión instalada sobre el stock disponible. En ocupación, la pendiente pre-COVID fue plana y no significativa (+0,05 puntos por año; $p=0,62$). En marzo de 2020 cayó $-11,7$ puntos y, en el período post-COVID, se mantiene $-2,6\%$ por debajo de lo esperado. Por lo tanto, la presión de camas no muestra un alza sostenida.

Esta distinción es clave para la gestión: el aumento se observa principalmente en flujo de egresos, no en camas ocupadas. El patrón es compatible con mayor rotación o cambios en el funcionamiento de la corta estadía, más que con una expansión sostenida del stock ocupado.



Fuente: MINSAL REM20 2014-2026

Figura 5. La ocupación de camas no reproduce el alza de egresos; tras la caída de marzo de 2020 permanece por debajo de lo esperado en el período post-COVID.

5. Salvedad metodológica

REM20 mide volumen y flujo de actividad hospitalaria, no diagnóstico clínico individual por patología. Por tanto, este análisis no permite afirmar qué cuadros clínicos específicos explican las hospitalizaciones ni establecer causalidad clínica a nivel de paciente. En consecuencia, el estudio responde la pregunta de hospitalizaciones por salud mental, pero no la de incremento de patologías psiquiátricas (incidencia de enfermedad), que constituye una segunda capa de análisis a partir de fuentes con diagnóstico —por ejemplo, egresos por CIE-10 (capítulo V, F00-F99) del DEIS o la actividad ambulatoria de salud mental—.

El análisis es agregado, con punto de interrupción fijo en marzo de 2020. El contrafactual utilizado es lineal y proyecta la tendencia pre-COVID bajo ese supuesto. Además, 2026 corresponde a un año parcial, por lo que debe interpretarse con cautela al comparar períodos completos y parciales.

La conclusión debe entenderse en ese marco: el estudio identifica patrones temporales y diferencias agregadas de flujo hospitalario, pero no afirma causalidad clínica. En particular, no se sostiene que el COVID haya provocado el aumento de hospitalización psiquiátrica.

6. Lectura de salud pública

La necesidad de hospitalización psiquiátrica parece responder a una dinámica estructural de largo plazo, no a un shock pandémico como origen del aumento. La tendencia ascendente ya estaba presente desde 2014 y debe ser considerada como base para la planificación de capacidad.

La planificación no debería apoyarse exclusivamente en la experiencia del período COVID, porque ese período incluyó una caída operacional inicial y una recuperación posterior. Una lectura más estable debe considerar la trayectoria completa 2014-2026, distinguiendo el efecto de interrupción transitoria de la tendencia de fondo.

Finalmente, dado que el crecimiento se expresa más claramente en egresos que en ocupación de camas, la respuesta no debería limitarse a agregar camas. El patrón sugiere reforzar los dispositivos ambulatorios, la continuidad de cuidados, la coordinación del egreso y los soportes post-alta, junto con revisar la capacidad hospitalaria cuando corresponda. El foco técnico no es solo aumentar stock, sino gestionar mejor el flujo asistencial de corta estadía.